

体检人群中脂肪肝患者的症状规律研究

罗志杰

[摘要] 目的 对体检人群中脂肪肝患者的症状规律进行研究。方法 选取受检的5000例脂肪肝患者,根据实验室检查结果对患者的症状规律进行分析。结果 脂肪肝好发于40~60岁人群,其中男性发病高于女性,比例1.7:1.0;脂肪肝能导致患者血脂(TC、TG和LDL-ch)及肝功能(AST、ALT及GGT)异常,其主要的症状为发热、盗汗、口苦、腹泻、便秘等。结论 体检人群中脂肪肝患者具有明显的不适症状,临床上应结合基本的症状规律,从而有针对性地进行治疗。

[关键词] 脂肪肝;体检人群;症状规律;临床研究

脂肪肝是指肝细胞发生脂肪病变,属于临床上的常见病,其并非独立的疾病,而是某些疾病在肝脏的疾病体现,轻症患者早期并无明显症状,重症患者病情凶猛^[1-2]。为了提高脂肪肝的早期发现率,应掌握其基本的症状规律,从而方便临床诊治。本研究对进行体检人群中的5000例脂肪肝患者进行了症状规律分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年8月~2014年8月在长江航运总医院体检中心进行体检的5000例脂肪肝患者,其中男3170例,女1830例,年龄19~73岁,平均年龄(43.6±11.8)岁。另选4800例年龄、性别和病情严重程度相近的健康人作为对照组。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:参加体检的人群、体检项目齐全、主要为单纯脂肪肝患者。排除标准:(1)肝炎患者,如乙肝、丙肝、药物性肝炎等;(2)妊娠妇女、哺乳期妇女;(3)患有自身免疫性肝脏疾病;(4)年龄在19~73岁之外^[3]。

1.3 方法 对患者进行常规体格检查,主要包括血压、身高和体质量等,并利用全自动生化分析仪检测患者的血液(TG、TC、ALT、AST等),其中乙肝5项利用ELISE方法检查^[4]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 15.0统计学软件进行数据的分析和处理,计量资料采用 $\bar{x} \pm s$ 表示,组间比较采用 t 检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用 χ^2 检验;以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 脂肪肝患者的年龄、性别分布 5000例脂肪肝患者中包括3170例男性,其中69例<30岁,236例30~39岁,1635例40~49岁,768例50~59岁,462例>60岁;1830例女性,

其中45例<30岁,126例30~39岁,682例40~49岁,857例50~59岁,120例>60岁,男女比例为1.7:1.0,其中脂肪肝好发于40~60岁人群。

2.2 脂肪肝患者的血脂变化 与健康人群组比较,脂肪肝组患者的TC、TG和LDL-ch均显著升高,2组比较差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表1。

表1 脂肪肝患者的血脂变化($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	TC	TG	LDL-ch	HDL-ch
脂肪肝组	5000	7.43±1.23	2.41±1.01	4.02±1.76	1.76±0.63
健康人群组	4800	4.34±0.89	1.22±0.75	2.54±0.98	1.79±0.79
P 值		<0.05	<0.05	<0.05	>0.05

2.3 脂肪肝患者的肝功能变化 与健康人群组比较,脂肪肝组患者的AST、GGT和ALT均显著升高,2组比较差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表2。

表2 脂肪肝患者的肝功能变化($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	AST(IU/L)	ALT(IU/L)	GGT(IU/L)
脂肪肝组	5000	39.56±23.74	79.37±20.46	68.48±34.15
健康人群组	4800	20.45±12.42	34.28±19.53	24.56±11.23
P 值		<0.05	<0.05	<0.05

2.4 脂肪肝的临床表现与合并症 脂肪肝患者并的临床症状表现并不一致,主要有食欲不振、乏力、恶心、呕吐、肝区隐痛、腹胀、肝脾肿大等,本组中有3425例患者具有明显的症状,比例为68.5%。同时本组脂肪肝患者同时合并高血压、糖尿病、冠心病、脑梗死等疾病。

作者单位:湖北 430010 长江航运总医院体检科(罗志杰)

术服务及流产后的保健服务,及时识别和处理流产并发症,为所有妇女提供计划生育咨询和指导,帮助妇女采取避孕措施,预防再次意外妊娠,提供与流产后服务相关的生殖健康保健服务。因此,大力推广规范化的PAC,是当今所有妇产科医务人员义不容辞的职责。 $\square$

参考文献

- [1] 中华医学会计划生育分会 人工流产后计划生育服务指南[J] 中华妇产科杂志,2011,46(4):319-320
- [2] 程怡民,周献 中国重复流产和流产后保健的现状[J] 国际生殖健康/计划生育杂志,2010,29(5):324-326

- [3] 李兴无,邹霞,刘为民 流产后服务干预对选择避孕方法和重复人工流产的影响[J] 中国医药指南,2013,11(21):462-463
- [4] 韩宇研,马黔红 人工流产后服务[J] 中国实用妇科与产科杂志,2009,25(10):747-749
- [5] 华桦,朱慧,曹曦霞 多次流产女性流产后服务需求及干预效果的探讨[J] 中国妇产科临床杂志,2013,14(6):490-492
- [6] 孙广范,林霞,王莹,等 医院内规范化流产后服务模式探讨[J] 中国计划生育学杂志,2012,20(7):470-473
- [7] 卢皖雯 社区规范开展流产后服务的必要性[J] 中国医学创新杂志,2010,7(29):37-38
- [8] 刘辉,李明颖 基层社区医院开展规范化流产后服务模式的探讨[J] 中国妇幼保健,2014,29(22):3547-3548

论亚健康与中医“治未病”的关系

万娟

【摘要】 目的 探讨中医对亚健康状态的防治效果。**方法** 阐述分析中医“治未病”思想,分析该思想对亚健康防治的干预效果。**结果** 中医治未病思想是通过心理调节、改善生活方式、药物治疗、运动干预、按摩以及气功治疗,防治亚健康。**结论** 亚健康疾病的防治中,应坚持中医学的治疗理论,养成一种健康的生活方式。

【关键词】 亚健康;治未病;中医

亚健康为一种临界状态,是指人虽然无明显的疾病,但表现为适应能力、精神活力以及反应力下降的情况,分析该状态的发生原因主要是由于人体代谢功能或生理功能明显下降、老化而导致^[1]。若该状态长期存在、不能得到及时的纠正,极易导致患者出现一系列的疾病。随着传统中医学的不断发展,以及人们对中医重视程度的不断提高,临床开始研究中医治未病思想用于防治亚健康状态的效果^[2]。本研究旨在探讨中医治未病思想在亚健康状态防治方面的意义。

1 亚健康状态的中医认知

中医学认为,人体健康的标志是阴阳平衡,是人与自然环境、社会环境达成一种和谐而形成的一种动态平衡。中医学上,并不存在“亚健康”这一概念,健康-亚健康-疾病-死亡这是一个连续、渐进的过程,是人体共中医学上所谓的阴平阳秘,到阴阳失衡,再到阴阳离绝的一种动态变化过程,而其中亚健康则是从健康到疾病转变的一个过渡期,是指“未病”状态^[3]。根据中医学的未病学理论,所谓的亚健康状态即指潜病态、前病态。

2 中医治未病概念

治未病这一理论是《黄帝内经》中关于中医学的防治思想^[4]。其概念是指在疾病发生前,提前做好预防措施,防止疾病的发生、发展以及恶化。治未病意义是指一方面是未病防治,另一方面是

指已病防止病变。“治未病”学术思想是指中医学理论体系的一个重要组成部分,提出一种较高水平的医学境界,且被后世医学家传承。晋代葛洪在《抱朴子·地真》中指出,“是以圣人消未起之患,医之于无事之前,不迫于既逝之后”^[5]。这一观点也被唐代孙思邈所认同,指出治未病是指从防病以及欲病早治着眼。未病防治重点强调预防疾病;已病防止病变则重点强调的是就疾病的现状、发展规律以及发展趋势,做好积极有效的合理性治疗措施,防止疾病在原有基础上发展以及恶化^[6]。治未病,坚持从事物运动特点考虑,既包括未病先防,同时也包括治疗非显性疾病,重视疾病前期先兆症状调理,观察病中、病后身体以及心理变化情况。在疾病不显著时,人们多会因疾病不显著而忽略,直至疾病恶化发展到全身,或出现局部典型性症状,才经诊断发病。在发病前的全部状态的未病阶段,若能采取有效的防范干预,可有效抑制疾病的恶化发展,起到防微杜渐的效果。在传统的中医学中,中医防病治病对于中医学的实践具有重要的指导意义。

3 中医“治未病”思想对亚健康状态防治干预

亚健康状态的预防包括:一是从健康到亚健康的预防,二是从亚健康到疾病的预防,也就是依据未病先防、即病变思想实施治疗。中医学讲求阴阳调和,因此临床治疗时,应注意平衡体内的阴阳、扶正祛邪^[7]。从宏观角度出发,采用综合调理方法,消除阴阳失调、异常等情况,从而达到增强患者身体免疫机制,促进患者康复的效果。

作者单位:江西 330046 江西省健康教育与促进中心(万娟)

3 讨论

肝脏是人体的重要器官,能调节脂肪的摄取和代谢、胆固醇的生成级脂蛋白的合成与分泌等^[8]。当患者存在肥胖、高血压、糖尿病、长期酗酒、营养不良、妊娠、药物等危险因素时,肝内的脂肪代谢平衡很容易被打乱,从而引发脂肪肝。随着生活水平的不断提高,脂肪肝的发病率也显著提升^[6-7]。

脂肪肝的形成与患者体内 VLDL 的浓度相关,当肝脏合成 TG 的速度过快,超过组成 VLDL 进入血液的速度时,患者的肝内就会发生 TG 蓄积,从而形成高 TG 血症,增加血液内的游离脂肪酸,干扰胰岛素的生理作用,进而发生胰岛素抵抗,胰岛素抵抗会反作用于肝脏,使肝脏合成 TG 和 VLDL。脂肪肝会逐步进展成肝硬化,使肝脏发生不可逆性转变,影响患者的存活质量,据相关资料统计,肥胖脂肪肝患者中大约有 1.5%~8%的患者可进展为肝硬化,因此,临床上应重视肥胖性脂肪肝^[8]。本研究中,脂肪肝患者的主要病因为肥胖、长期酗酒、高血脂、高血压、糖尿病。

综上所述,脂肪肝患者具有自身的症状体征,临床治疗时应根据患者的具体表现做出合理的诊断与治疗,以促进患者的早期

康复。□

参考文献

- [1] 李方玲 体检人群中脂肪肝患者的症状规律与舌象特征研究[D] 北京:北京中医药大学,2006
- [2] 汤净 脂肪肝临床特点分析[J] 海南医学院学报,2000,6(1):14-16
- [3] 贾燕,徐灿霞,王芬,等 非酒精性脂肪肝患者 210 例临床分析[J] 中南大学学报(医学版),2009,34(9):910-913
- [4] 王召平,李方玲,王盛花,等 体检人群中脂肪肝患者的行为因素调查[J] 中国自然医学杂志,2007,9(5):377-380
- [5] 毛炳飞,周飞,薛付忠 蚌埠市区健康体检人群脂肪肝检出率及流行病学特点分析[J] 中华全科医学,2014,12(2):262-264
- [6] 张蓉 普通 B 超在体检人群中检出脂肪肝的临床观察[J] 中外医学研究,2014,12(16):68-69
- [7] 成昌盛,龚秀琴,黄美 1379 例脂肪肝患者的相关影响因素分析[J] 护理学报,2013,20(10B):29-32
- [8] 黄静 健康体检人群中脂肪肝的检出与分析[J] 检验医学与临床,2011,8(7):869